

Apostila Premium - Conhecimentos Específicos: Técnico em Enfermagem

Arquivo-fonte: apostilas/ensino_medio_tecnico/conhecimentos_especificos_tecnico_em_enfermagem.md

Apostila Premium - Conhecimentos Específicos: Técnico em Enfermagem

Concurso: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte/ES

Edital: nº 001/2026, consolidado com as retificações nº 001/2026 e nº 002/2026

Cargo: Técnico em Enfermagem

Objetivo: material-base completo, didático e aderente ao Anexo II

Roteiro de estudo

O programa do edital é extenso. Para evitar memorização solta, os capítulos seguem a sequência do cuidado: compreender a pessoa, observar, registrar, executar procedimentos com segurança, prevenir infecções, reconhecer riscos clínicos e agir dentro dos limites éticos e legais.

Regra de estudo

Em enfermagem, a banca costuma alterar uma etapa da técnica, trocar um conceito semelhante ou transformar uma conduta segura em conduta absoluta. Leia cada alternativa perguntando: a ação protege o paciente, respeita a prescrição, segue protocolo institucional e está dentro da competência profissional?

Rastreabilidade do conteúdo programático

Item do edital	Onde estudar
Programa de Humanização	Capítulo 1
Fundamentos, observação e registros	Capítulos 2, 5A e 18
Sinais vitais e antropometria	Capítulos 3 e 19
Medicação oral, intradérmica, intramuscular e intravenosa	Capítulo 4
Cálculo de medicamentos e gotejamento	Capítulos 11A, 22 e 23
Limpeza, desinfecção, esterilização e transporte	Capítulo 5
Coleta de material	Capítulos 6 e 20
Lesão por pressão	Capítulos 7 e 18
Curativos, bandagens, calor e frio	Capítulos 8 e 21
Oxigenoterapia e nebulização	Capítulo 9
Cateterismo e sondagem	Capítulos 9 e 9A
Balanço hídrico	Capítulo 10
Infecção hospitalar e biossegurança	Capítulo 11
Médico-cirúrgica	Capítulos 12 e 16
Clínica e terapia intensiva	Capítulos 13, 13A, 15 e 17
Crianças intubadas, traqueostomizadas e sob assistência ventilatória	Capítulo 17
Código de Ética e limites profissionais	Capítulos 14 e 14A

Capítulo 1 - Humanização da assistência

1. Introdução

Humanizar não significa apenas tratar a pessoa com cordialidade. Significa prestar cuidado tecnicamente seguro e respeitoso, considerando dignidade, privacidade, autonomia, singularidade, escuta e contexto social.

2. Cuidado centrado na pessoa

O paciente não é "o leito", "a doença" ou "o procedimento". Antes de executar uma técnica, o profissional deve identificar a pessoa, explicar o que será feito, preservar sua intimidade e observar dúvidas, medo, dor ou desconforto.

Condutas concretas

- chamar a pessoa pelo nome;
- confirmar identificação antes de procedimentos;
- usar linguagem compreensível;
- pedir consentimento e explicar etapas;
- proteger o corpo contra exposição desnecessária;
- acolher dúvidas;
- respeitar diferenças culturais, religiosas e pessoais;
- comunicar intercorrências;
- registrar o cuidado realizado.

3. Acolhimento e escuta

Acolhimento é postura de escuta e responsabilização. Não é apenas recepção administrativa. Uma queixa aparentemente simples pode revelar risco quando o profissional escuta com atenção.

Exemplo: uma pessoa internada relata "cansaço diferente" e ansiedade. Ignorar o relato porque a pressão arterial está normal é inadequado. O técnico deve observar, verificar parâmetros pertinentes e comunicar a equipe.

4. Principais erros em prova

- confundir humanização com ausência de normas;
- acreditar que privacidade pode ser dispensada em procedimentos rotineiros;
- infantilizar idosos;
- omitir explicações porque o procedimento é simples.

5. Questões comentadas

1. Uma prática humanizada é:

- A) executar o procedimento sem explicar para poupar tempo
- B) chamar o paciente pelo diagnóstico
- C) preservar privacidade e comunicar etapas do cuidado
- D) impedir perguntas do familiar em qualquer hipótese

Resposta: C. Segurança e respeito caminham juntos.

6. Resumo do capítulo

Humanização envolve cuidado integral, escuta, privacidade, autonomia, informação e responsabilidade.

Capítulo 2 - Observação, sinais, sintomas e registros

1. Sinais e sintomas

Sinal é dado observável ou mensurável. **Sintoma** é experiência relatada pela pessoa.

Tipo	Exemplos
Sinal	temperatura elevada, palidez, edema, pressão arterial alterada
Sintoma	dor, náusea, tontura, sensação de falta de ar

O relato subjetivo não deve ser desprezado. Dor, por exemplo, exige avaliação e registro ainda que não exista alteração visível.

2. Observação sistemática

Observar é comparar o estado atual com o esperado e com registros anteriores. Mudanças podem indicar agravamento.

Pontos frequentes

- nível de consciência;
- comportamento;
- coloração e integridade da pele;
- respiração;
- dor;
- eliminações;
- aceitação de dieta;
- mobilidade;
- presença de edema;
- funcionamento de dispositivos.

3. Registro de enfermagem

Registro é parte do cuidado e documento profissional. Deve ser claro, objetivo, cronológico, legível e verdadeiro. Registre o que observou, o que fez, o horário, a resposta do paciente e as comunicações

relevantes, conforme rotina institucional.

Evite

- julgamentos pessoais;
- termos vagos como “bem” ou “normal” sem contexto;
- rasuras inadequadas;
- omissão de intercorrências;
- registrar procedimento não realizado;
- usar abreviações não padronizadas.

Exemplo inadequado: “Paciente ruim.”

Exemplo melhor: “Às 14h10, paciente refere dor intensa em região abdominal, intensidade 8/10. Enfermeiro comunicado.”

Pegadinha

Registrar não substitui comunicar situação urgente. Em risco clínico, comunique imediatamente e depois formalize o registro.

4. Questões comentadas

1. Dor referida pelo paciente é:

- A) sinal exclusivamente objetivo
- B) sintoma que deve ser avaliado e registrado
- C) dado irrelevante sem alteração laboratorial
- D) diagnóstico fechado

Resposta: B.

2. O registro adequado deve:

- A) conter julgamento pessoal
- B) ser objetivo e cronológico
- C) omitir a resposta do paciente
- D) ser realizado antes do procedimento

Resposta: B.

5. Resumo do capítulo

Observe, reconheça mudanças, comunique risco e registre fatos com precisão.

Capítulo 3 - Sinais vitais e dados antropométricos

Percurso de aprendizagem

Este capítulo apresenta conceitos. O Capítulo 19 retoma sinais vitais como oficina técnica, com aplicação e erros frequentes.

1. Introdução

Sinais vitais auxiliam a avaliar funções essenciais e tendências clínicas. Um valor isolado precisa ser interpretado considerando contexto, histórico, idade, condição clínica e protocolo.

2. Temperatura

Temperatura corporal reflete equilíbrio entre produção e perda de calor. Técnica, local de aferição, equipamento e condição do paciente interferem no resultado.

Cuidados

- higienizar as mãos;
- identificar paciente;
- explicar procedimento;
- conferir equipamento;
- respeitar local e técnica;
- registrar valor, horário e local quando pertinente;
- comunicar alterações relevantes.

3. Pulso

Avalie frequência, ritmo e amplitude conforme técnica aplicável. Não registre somente número se observar irregularidade.

4. Respiração

Observe frequência, ritmo, profundidade, esforço respiratório, ruídos audíveis, uso de musculatura acessória e coloração. Sempre que indicado, observe saturação periférica de oxigênio com atenção às limitações do equipamento.

5. Pressão arterial

Aferição correta exige manguito adequado, posicionamento apropriado, repouso quando aplicável e técnica padronizada. Manguito inadequado pode distorcer a medida.

6. Dor

Dor é experiência individual. Avalie localização, intensidade, característica, início, fatores de melhora ou piora e resposta às medidas adotadas.

7. Antropometria

Peso, altura e circunferências podem apoiar avaliação nutricional, cálculo de doses e acompanhamento clínico. Use equipamento apropriado e registre corretamente.

8. Erros comuns

- medir sem conferir identificação;
- ignorar tendência de piora porque um valor isolado parece aceitável;
- não comunicar alteração;
- registrar dado de memória muito tempo depois.

9. Questões comentadas

1. Em relação à pressão arterial, é correto:

- A) tamanho do manguito não interfere
- B) técnica e posicionamento interferem no resultado
- C) basta registrar sem comunicar alteração
- D) identificação é dispensável

Resposta: B.

10. Resumo do capítulo

Sinais vitais exigem técnica, interpretação contextual, registro oportuno e comunicação de alterações.

Capítulo 4 - Administração segura de medicamentos

Primeiro compreenda as conferências e vias. Depois estude os Capítulos 11A, 22 e 23 para diluição, conversões e prática de cálculo.

1. Introdução

Administrar medicamentos exige leitura atenta da prescrição, identificação correta e prevenção de erros. O técnico atua conforme competência, prescrição, orientação do enfermeiro e protocolos institucionais.

2. Conferências de segurança

Materiais didáticos apresentam listas com diferentes quantidades de “certos” da medicação. Para prova e prática, compreenda o núcleo: paciente, medicamento, dose, via, horário, registro, indicação, orientação, forma/apresentação e resposta.

Conferência	Pergunta
Paciente certo	confirme por identificadores adequados
Medicamento certo	confira nome e apresentação
Dose certa	compare prescrição, concentração e cálculo
Via certa	confirme via prescrita
Horário certo	observe frequência e intervalos
Registro certo	documente administração e intercorrências
Resposta	observe efeito esperado e reações

Atenção

Dúvida não se resolve por adivinhação. Prescrição ilegível, dose incompatível ou informação incompleta exige esclarecimento antes da administração.

3. Via oral

Confirme capacidade de deglutição, restrições, forma farmacêutica e orientação. Não triture medicamentos por decisão própria: algumas apresentações não podem ser alteradas.

4. Via intradérmica

É utilizada em situações específicas, com pequeno volume e aplicação na derme. A técnica busca formação de pequena pápula. Siga protocolo quanto a local, ângulo e material.

5. Via intramuscular

Exige escolha adequada do sítio considerando idade, massa muscular, medicamento, volume e protocolo. Higienização, preparo, descarte e observação de reações são essenciais.

6. Via intravenosa

Possui ação rápida e exige vigilância. Confira acesso, compatibilidade, diluição, velocidade e sinais de complicação. Dor, edema, vermelhidão, endurecimento ou extravasamento exigem avaliação.

7. Cálculo de dose

Regra básica

Se a prescrição pede uma quantidade e a apresentação disponível informa outra, organize a proporção:

Dose prescrita x volume disponível / dose disponível = volume a administrar

Exemplo: prescrição de 250 mg; frasco com 500 mg em 2 mL.

$$250 \times 2 / 500 = 1 \text{ mL}$$

Cálculo de gotejamento

Para equipo macrogotas:

$$\text{gotas/minuto} = \text{volume (mL)} \times \text{fator de gotejamento} / \text{tempo (minutos)}$$

Exemplo: 500 mL em 5 horas, equipo com fator 20 gotas/mL.

Tempo: $5 \times 60 = 300 \text{ minutos}$

Cálculo: $500 \times 20 / 300 = 33,3$

Resultado aproximado: **33 gotas/minuto**.

Para microgotas, confirme o fator do equipo utilizado.

8. Erros comuns

- usar horas sem converter para minutos;
- esquecer unidade de medida;
- confundir dose prescrita com dose disponível;
- administrar sem esclarecer prescrição duvidosa;
- desprezar reação do paciente.

9. Questões comentadas

1. Prescrição de 300 mg. Disponível: 600 mg em 4 mL. Volume:

- A) 1 mL
- B) 2 mL
- C) 4 mL
- D) 8 mL

Resposta: B. $300 \times 4 / 600 = 2$.

2. Diante de prescrição ilegível, o técnico deve:

- A) escolher dose provável
- B) pedir esclarecimento antes de administrar
- C) administrar metade
- D) ignorar a prescrição

Resposta: B.

10. Resumo do capítulo

Medicação segura exige conferências, cálculo correto, respeito à via, esclarecimento de dúvidas e observação da resposta.

Capítulo 5 - Unidade do paciente, limpeza, desinfecção e esterilização

1. Conceitos essenciais

Processo	Finalidade
Limpeza	remover sujidade e matéria orgânica; etapa fundamental
Desinfecção	eliminar muitos microrganismos patogênicos em objetos inanimados, conforme nível e processo
Esterilização	destruir todas as formas de vida microbiana, inclusive esporos

Não confunda esterilização com limpeza intensiva. São processos diferentes e dependem de indicação conforme material e uso.

2. Unidade do paciente

Inclui ambiente imediato, cama, roupas, mobiliário, suportes e equipamentos. Organização reduz risco de quedas, contaminação e perda de materiais.

3. Material hospitalar

O processamento envolve etapas como recebimento, limpeza, inspeção, preparo, acondicionamento, esterilização quando indicada, armazenamento e distribuição conforme fluxo institucional.

Classificação pelo risco

A classificação ajuda a decidir o processamento mínimo necessário.

Tipo de produto	Uso geral	Processamento mínimo após limpeza
Crítico	penetra tecidos estéreis ou sistema vascular	esterilização
Semicrítico	entra em contato com mucosa íntegra ou pele não íntegra	desinfecção de alto nível, ressalvadas regras específicas
Não crítico	contato com pele íntegra	limpeza, no mínimo

Pegadinha

Limpeza vem antes da desinfecção ou esterilização. Matéria orgânica compromete o processamento.

Fluxo no CME

Segundo a RDC nº 15/2012, o processamento deve seguir fluxo direcionado da área suja para a área limpa. A lógica evita contaminação cruzada:

1. pré-limpeza quando aplicável;
2. recepção;
3. limpeza;
4. secagem;
5. inspeção de integridade e funcionalidade;
6. preparo e acondicionamento;
7. desinfecção ou esterilização indicada;
8. armazenamento;
9. distribuição.

Integridade da embalagem

Embalagem úmida, rasgada, aberta ou com integridade comprometida impede considerar o material seguro para uso estéril.

4. Transporte

Material contaminado e material processado devem seguir fluxos que previnam cruzamento e recontaminação.

5. Questões comentadas

1. O processo capaz de destruir todas as formas de vida microbiana, inclusive esporos, é:

- A) limpeza
- B) esterilização
- C) varredura
- D) organização

Resposta: B.

2. Produto utilizado em procedimento invasivo com penetração em tecido estéril deve ser classificado como:

- A) não crítico
- B) crítico
- C) administrativo
- D) dispensável

Resposta: B. Produtos críticos exigem esterilização após limpeza e demais etapas.

3. O fluxo adequado do processamento segue:

- A) área limpa para área suja
- B) área suja para área limpa
- C) qualquer direção
- D) armazenamento antes da limpeza

Resposta: B.

6. Resumo do capítulo

Limpeza remove sujidade; desinfecção reduz ou elimina microrganismos conforme nível; esterilização elimina todas as formas microbianas.

Capítulo 5A - Preparo da unidade, higiene e conforto do paciente

1. Introdução

Fundamentos de enfermagem incluem cuidados cotidianos que parecem simples, mas interferem diretamente na segurança. Organizar a unidade, ajudar na higiene e manter conforto exigem técnica,

observação e respeito.

2. Preparo da unidade

A unidade deve permanecer organizada, funcional e livre de obstáculos. Materiais precisam estar disponíveis conforme necessidade, sem excesso que atrapalhe circulação ou higienização.

Verifique

- cama e grades conforme avaliação;
- roupas limpas e sem dobras desnecessárias;
- campainha ou meio de chamada acessível;
- objetos pessoais organizados;
- dispositivos sem tração;
- piso seco;
- descarte correto de resíduos;
- privacidade.

3. Higiene corporal

Higiene promove conforto e permite observar pele, mucosas, dor, mobilidade e estado geral. Explique etapas, estimule autonomia possível e evite exposição.

4. Mudança de decúbito

Reposicionamento auxilia conforto e prevenção de lesão por pressão. Deve considerar quadro clínico, tolerância, dispositivos e plano individualizado.

5. Questão comentada

1. Na organização da unidade:

- A) dobras no lençol são irrelevantes
- B) obstáculos podem elevar risco de queda
- C) dispositivos podem permanecer tracionados
- D) privacidade é dispensável

Resposta: B.

6. Resumo

Unidade organizada, higiene respeitosa e posicionamento adequado previnem riscos e promovem dignidade.

Capítulo 6 - Coleta de materiais para exames

Percurso de aprendizagem

Este capítulo introduz o fluxo seguro. O Capítulo 20 aprofunda a fase pré-analítica e a identificação.

1. Princípios

Coleta inadequada pode comprometer o resultado. O cuidado começa antes da obtenção da amostra e termina somente após identificação e encaminhamento corretos.

2. Etapas

1. conferir solicitação;
2. identificar paciente corretamente;
3. explicar procedimento;
4. observar preparo necessário;
5. separar recipiente adequado;
6. higienizar mãos e utilizar EPI indicado;
7. coletar conforme técnica;
8. identificar amostra;
9. encaminhar em prazo e condições adequados;
10. registrar quando previsto.

3. Erros comuns

- identificar amostra de forma incompleta;
- contaminar material;
- utilizar recipiente errado;
- desconsiderar tempo de encaminhamento;
- ignorar preparo do paciente.

4. Questão comentada

1. Uma medida fundamental após a coleta é:

- A) encaminhar material sem identificação
- B) identificar corretamente a amostra
- C) trocar recipiente sem motivo
- D) deixar material exposto

Resposta: B.

5. Resumo do capítulo

Qualidade do exame depende de identificação, técnica, recipiente, conservação e encaminhamento.

Capítulo 7 - Lesão por pressão, mobilização e conforto

1. Conceito

Lesão por pressão é dano localizado na pele e/ou tecido subjacente, geralmente sobre proeminência óssea ou relacionado a dispositivo, resultante de pressão ou pressão combinada com cisalhamento.

2. Fatores de risco

- imobilidade;
- umidade;
- nutrição inadequada;
- redução de sensibilidade;
- fricção e cisalhamento;
- alterações circulatórias;
- uso de dispositivos;
- estado clínico grave.

3. Prevenção

- inspecionar pele;
- manter pele limpa e seca;
- reposicionar conforme plano individualizado;
- evitar dobras no lençol;
- observar proeminências ósseas;
- usar superfícies de apoio quando indicadas;
- observar dispositivos;
- comunicar alterações;
- registrar cuidados.

Pegadinha

Mudança de posição é importante, mas não é medida isolada nem receita idêntica para todas as pessoas. O plano depende de avaliação individual.

4. Questões comentadas

1. Na prevenção de lesão por pressão:

- A) apenas reposicionar é suficiente em qualquer caso
- B) inspeção de pele e controle de umidade são relevantes
- C) dobras no lençol não interferem
- D) dispositivos não oferecem risco

Resposta: B.

5. Resumo do capítulo

Prevenção combina avaliação, reposicionamento individualizado, cuidado com pele, umidade, nutrição e dispositivos.

Capítulo 8 - Curativos, bandagens e aplicações quentes e frias

Percurso de aprendizagem

Este capítulo oferece fundamentos. O Capítulo 21 funciona como oficina de avaliação, registro e tomada de decisão.

1. Curativos

Curativo busca proteger a lesão, favorecer ambiente adequado à cicatrização e permitir observação. Técnica e cobertura dependem de avaliação e prescrição ou protocolo.

Observe

- localização e dimensões;
- tipo e quantidade de exsudato;
- odor;
- aspecto do leito;
- pele ao redor;
- dor;
- sinais de infecção;
- resposta ao cuidado.

2. Bandagens

Podem proteger, fixar ou oferecer compressão quando indicada. Aplicação inadequada pode comprometer circulação.

Sinais de alerta após bandagem

- dor crescente;
- palidez ou cianose;
- extremidade fria;
- formigamento;
- edema;
- redução de mobilidade.

3. Aplicações quentes e frias

Devem seguir indicação, tempo e proteção da pele. Calor e frio aplicados inadequadamente podem causar lesão.

4. Questões comentadas

1. Após bandagem, extremidade fria e arroxeadas exige:

- A) ignorar porque é esperado
- B) avaliação imediata e comunicação
- C) apertar mais a bandagem
- D) aguardar alta

Resposta: B.

5. Resumo do capítulo

Curativos e bandagens exigem avaliação, técnica, observação da pele e identificação precoce de complicações.

Capítulo 9 - Oxigenoterapia, nebulização e dispositivos

1. Oxigenoterapia

Oxigênio é medicamento. Deve ser utilizado conforme indicação, dispositivo e fluxo prescritos, com observação da resposta clínica.

Cuidados

- conferir prescrição;
- instalar dispositivo corretamente;
- observar permeabilidade;
- proteger pele em pontos de contato;
- manter segurança contra fontes de ignição;
- observar desconforto e resposta;
- registrar.

2. Nebulização

Administra solução ou medicamento em aerossol conforme prescrição. Oriente o paciente, confira dispositivo, observe tolerância e higienize conforme rotina.

3. Cateterismo vesical

Procedimento invasivo associado a risco de infecção e trauma. Exige indicação, técnica asséptica, fixação adequada, sistema conforme protocolo, cuidado com posicionamento e registro.

4. Sondagem gástrica

Exige indicação, técnica, verificação conforme protocolo, observação de sinais de intolerância e prevenção de complicações.

5. Questões comentadas

1. Em oxigenoterapia:

- A) fluxo pode ser alterado livremente
- B) oxigênio deve ser tratado como medicamento
- C) risco de ignição é irrelevante
- D) resposta clínica dispensa observação

Resposta: B.

6. Resumo do capítulo

Dispositivos e terapias exigem indicação, técnica, vigilância e registro.

Capítulo 9A - Segurança no uso de cateteres e sondas

1. Introdução

Cateteres e sondas podem ser necessários para o cuidado, mas aumentam risco de trauma, infecção, deslocamento e obstrução. A melhor prática combina indicação adequada, técnica, manutenção e retirada assim que deixarem de ser necessários, conforme avaliação competente.

2. Cateter vesical

Observe

- fixação;
- posicionamento do sistema;
- fluxo urinário;
- volume e aspecto quando pertinente;
- presença de dor;
- sinais de obstrução;
- integridade do sistema;
- indicação de manutenção.

Evite manipulações desnecessárias. Registre volumes quando incluídos no balanço.

3. Sondas gástricas

Observe fixação, posição conforme verificação protocolar, tolerância, pele, permeabilidade e risco de retirada acidental. Não administre dieta ou medicamento sem checagem prevista pelo serviço.

4. Prevenção de eventos

Antes de mobilizar paciente, confira dispositivos. Após transferência, confirme que não houve tração, dobra ou desconexão.

5. Questão comentada

1. Antes de transferir paciente com dispositivos, o técnico deve:

- A) ignorar fixações
- B) conferir dispositivos e prevenir tração
- C) desconectar tudo automaticamente
- D) suspender registro

Resposta: B.

6. Resumo

Dispositivos exigem vigilância contínua e prevenção de manipulação ou deslocamento indevido.

Capítulo 10 - Balanço hídrico

1. Conceito

Balanço hídrico compara entradas e saídas de líquidos em determinado período. Ajuda a acompanhar pacientes com risco de desequilíbrio.

2. Entradas e saídas

Entradas	Saídas
líquidos ingeridos	urina
dieta líquida ou enteral	vômitos
soluções intravenosas	drenagens
medicamentos diluídos	evacuações líquidas
outros volumes contabilizados conforme rotina	aspirações e outras perdas mensuráveis

3. Cálculo

Balanço = total de entradas - total de saídas

Exemplo: entradas de 1.800 mL e saídas de 1.250 mL:

$1.800 - 1.250 = +550 \text{ mL}$

O valor precisa ser interpretado conforme quadro clínico.

4. Questão comentada

1. Entradas de 1.500 mL e saídas de 1.900 mL resultam em:

- A) +400 mL
- B) -400 mL
- C) +3.400 mL
- D) zero

Resposta: B.

5. Resumo do capítulo

Registre entradas e saídas com precisão e comunique alterações relevantes.

Capítulo 11 - Infecções relacionadas à assistência e biossegurança

1. Introdução

Prevenir infecções protege paciente, trabalhador e comunidade. Higienização das mãos é medida central, mas integra um conjunto de práticas.

2. Precauções padrão

Aplicam-se ao cuidado de todas as pessoas, conforme risco de exposição. Incluem higiene das mãos, uso indicado de EPI, segurança com perfurocortantes, limpeza e descarte adequado.

3. Higienização das mãos

Realize conforme indicação e técnica. O uso de luvas não substitui higiene das mãos.

Pegadinha

Luva é barreira, não autorização para ignorar higiene das mãos. Troca de luvas e higiene seguem indicações próprias.

4. Perfurocortantes

- descarte imediatamente em coletor apropriado;
- não ultrapasse limite indicado do recipiente;
- evite manipulações desnecessárias;
- siga protocolo em caso de exposição ocupacional.

5. Segurança do paciente

A RDC nº 36/2013 prevê ações de gestão de risco, incluindo identificação do paciente, higiene das mãos, segurança cirúrgica, segurança em medicamentos, prevenção de quedas e prevenção de lesão por pressão.

6. Identificação do paciente

Confirme a identidade conforme protocolo antes de administrar medicamento, coletar material, encaminhar ou realizar procedimento. Número do leito ou localização física não substituem identificadores seguros.

Exemplo: duas pessoas podem possuir nomes parecidos. A conferência precisa seguir os identificadores definidos pelo serviço.

7. Prevenção de quedas

Observe risco individual, mobilidade, confusão, uso de medicamentos, obstáculos, iluminação, grades quando indicadas, campainha acessível e necessidade de auxílio.

8. Comunicação efetiva

Informações incompletas durante passagem de plantão ou transferência aumentam risco. Comunique situação clínica, alterações, alergias, dispositivos, cuidados pendentes e riscos relevantes conforme instrumento institucional.

9. Questões comentadas

1. O uso de luvas:

- A) substitui higienização das mãos
- B) dispensa descarte adequado
- C) não substitui higienização das mãos
- D) elimina risco de acidente

Resposta: C.

2. Para identificar paciente antes de procedimento:

- A) número do leito é suficiente
- B) devem ser utilizados identificadores conforme protocolo
- C) aparência basta
- D) confirmação é desnecessária em rotina

Resposta: B.

10. Resumo do capítulo

Precauções padrão, higiene das mãos, EPI, descarte e gestão de riscos reduzem eventos evitáveis.

Capítulo 11A - Preparo, diluição e prevenção de erros de medicação

1. Leitura ativa da prescrição

Antes de preparar, confira nome, apresentação, dose, via, horário, diluente quando aplicável, velocidade e paciente. Compare com alergias registradas e observe incompatibilidades ou dúvidas.

2. Conversões frequentes

Relação	Equivalência
1 g	1.000 mg
1 mg	1.000 mcg
1 L	1.000 mL

Exemplo: uma prescrição pede 0,5 g . Isso equivale a 500 mg .

3. Regra de três com concentração

Disponível: 1 g em 10 mL . Prescrito: 250 mg .

Converta primeiro: 1 g = 1.000 mg .

1.000 mg -> 10 mL

250 mg -> x

$x = 250 \times 10 / 1.000 = 2,5 \text{ mL}$.

4. Gotejamento: leitura cuidadosa

Antes da fórmula:

1. confirme volume total;
2. converta horas em minutos;
3. confirme fator do equipo;
4. calcule;
5. avalie coerência do resultado;
6. registre conforme rotina.

5. Situações de risco

- nomes semelhantes;
- apresentações diferentes;
- vírgula decimal;
- dose fora do habitual;
- interrupções durante preparo;
- paciente com alergia;
- via incompatível.

Regra de ouro

Se o cálculo parece estranho ou a prescrição gera dúvida, pare e esclareça.

6. Questões comentadas

1. 0,75 g equivalem a:

- A) 75 mg
- B) 750 mg
- C) 7.500 mg
- D) 0,075 mg

Resposta: B.

2. Disponível 500 mg em 5 mL ; prescrito 200 mg . Volume:

- A) 1 mL
- B) 2 mL
- C) 5 mL
- D) 10 mL

Resposta: B. $200 \times 5 / 500 = 2$.

7. Resumo

Cálculo seguro começa com unidades padronizadas e termina com conferência crítica.

Capítulo 12 - Assistência médico-cirúrgica

Percurso de aprendizagem

Estude os períodos cirúrgicos aqui e aprofunde vigilância e segurança no Capítulo 16.

1. Pré-operatório

O cuidado pré-operatório prepara paciente e reduz riscos. Observe identificação, orientações, jejum conforme prescrição, preparo indicado, exames, alergias, sinais vitais e checklist institucional.

2. Transoperatório

Envolve segurança, identificação, posicionamento, controle de materiais e cumprimento do protocolo conforme função profissional.

3. Pós-operatório

Observe:

- consciência;
- respiração;
- sinais vitais;
- dor;
- sangramento;
- curativo;
- drenos;
- eliminações;
- náuseas e vômitos;
- perfusão;
- resposta ao cuidado.

Aplicação em prova

Piora do nível de consciência, sangramento relevante ou alteração respiratória não devem aguardar anotação de rotina: exigem comunicação imediata.

4. Questões comentadas

1. No pós-operatório, alteração respiratória exige:

- A) aguardar visita seguinte
- B) comunicação imediata
- C) apenas registro no fim do plantão
- D) oferecer alimento

Resposta: B.

5. Resumo do capítulo

O cuidado cirúrgico prioriza identificação, prevenção de riscos e vigilância para reconhecer complicações.

Capítulo 13 - Assistência clínica e terapia intensiva

Percurso de aprendizagem

Este capítulo oferece panorama. Os Capítulos 15 e 17 aprofundam clínica e terapia intensiva; o Capítulo 13A treina reconhecimento de deterioração.

1. Diabetes

Observe glicemia quando indicada, sinais de hipoglicemia e hiperglicemia, aceitação alimentar, medicação e alterações clínicas.

Hipoglicemia: atenção

Pode envolver sudorese, tremores, palidez, alteração de comportamento, fraqueza ou redução do nível de consciência. A conduta deve seguir protocolo e ser comunicada.

2. Condições cardiovasculares

Observe pressão arterial, pulso, dor torácica, dispneia, edema, perfusão e mudanças súbitas.

3. Condições respiratórias

Pneumonia, asma, bronquite e outras condições podem alterar frequência respiratória, esforço, ausculta conforme avaliação habilitada, saturação, tosse, secreção e coloração.

4. Condições renais

Observe diurese, aspecto da urina quando pertinente, edema, pressão arterial, peso e balanço hídrico.

5. Terapia intensiva

Paciente crítico exige vigilância contínua, cuidado com dispositivos, prevenção de infecção, comunicação rápida e registros precisos. O técnico integra a equipe e executa cuidados conforme planejamento e supervisão.

6. Crianças com dispositivos respiratórios

O edital menciona cuidados com crianças intubadas, traqueostomizadas e sob assistência ventilatória. Nesses casos, atenção redobrada para permeabilidade de vias aéreas, fixação e integridade dos dispositivos, higiene, sinais de desconforto, parâmetros observáveis e comunicação imediata de alterações.

7. Questões comentadas

1. Sudorese, tremores e alteração de consciência em pessoa com diabetes sugerem necessidade de:

- A) ignorar até próxima rotina
- B) avaliação rápida e comunicação conforme protocolo
- C) suspender registros
- D) estimular caminhada sem avaliação

Resposta: B.

8. Resumo do capítulo

Na clínica e UTI, reconhecer alteração precocemente é tão importante quanto executar procedimentos.

Capítulo 13A - Raciocínio diante de sinais de alerta

1. Introdução

O técnico não precisa formular diagnóstico médico para reconhecer deterioração. Deve observar mudança, verificar dados pertinentes, comunicar rapidamente e agir conforme protocolo.

2. Alertas respiratórios

- dificuldade para respirar;
- queda de saturação quando monitorada;
- cianose;
- alteração súbita da frequência;
- uso de musculatura acessória;
- redução de consciência;
- secreção com dificuldade de eliminação.

3. Alertas circulatórios e neurológicos

- dor torácica;
- palidez intensa;
- sudorese fria;
- pressão muito alterada;
- alteração de pulso;
- confusão;
- redução de consciência;
- fraqueza súbita;
- convulsão.

4. Sangramento e pós-operatório

Observe curativos, drenos, perfusão e sinais vitais. Sangramento relevante ou piora rápida requer comunicação imediata.

5. Comunicação estruturada

Ao comunicar, informe:

- quem é o paciente;
- qual alteração foi observada;
- quando começou;
- dados mensurados;
- cuidados já realizados;
- resposta obtida.

6. Questão comentada

1. Em paciente com dispneia súbita e cianose, o técnico deve:

- A) aguardar próximo plantão
- B) comunicar imediatamente e seguir protocolo
- C) registrar somente ao final
- D) oferecer alimentação

Resposta: B.

7. Resumo

Reconhecer deterioração e comunicar prontamente reduz atraso no cuidado.

Capítulo 14 - Ética profissional

1. Referência

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem foi aprovado pela Resolução Cofen nº 564/2017 e se aplica também a técnicos de enfermagem.

2. Princípios práticos

- respeitar dignidade e direitos humanos;
- atuar com competência e responsabilidade;
- preservar sigilo;
- registrar informações necessárias;
- comunicar riscos e intercorrências;
- recusar prática insegura fora de competência ou sem condições adequadas, conforme normas;
- não praticar negligência, imprudência ou imperícia;
- respeitar limites legais da função.

3. Conceitos recorrentes

Conceito	Explicação
Negligência	omissão de cuidado devido
Imprudência	ação precipitada, sem cautela necessária
Imperícia	insuficiência de conhecimento ou habilidade técnica para a ação

Exemplo: deixar de comunicar alteração clínica observada pode caracterizar omissão relevante. Realizar procedimento para o qual não possui competência técnica pode envolver imperícia e infração ética.

4. Sigilo

Informações devem ser protegidas. Conversas em corredores, exposição em redes sociais e acesso indevido a dados violam privacidade. Compartilhamento pertinente com equipe envolvida no cuidado deve observar finalidade profissional.

5. Questões comentadas

1. O técnico deixa de realizar cuidado prescrito sem justificativa e sem comunicar. A situação se aproxima de:

- A) negligência
- B) regionalização
- C) integralidade
- D) humanização

Resposta: A.

2. Divulgar imagem do paciente em rede social sem autorização é:

- A) prática educativa automática
- B) violação de privacidade e sigilo
- C) dever profissional
- D) registro adequado

Resposta: B.

6. Resumo do capítulo

Ética orienta decisões cotidianas. Competência técnica, sigilo, registro e responsabilidade são indissociáveis.

Capítulo 14A - Exercício profissional e limites de atuação

1. Introdução

O técnico em enfermagem não atua em espaço sem regras. A Lei nº 7.498/1986 regulamenta o exercício da enfermagem e o Decreto nº 94.406/1987 detalha atribuições. Compreender limites protege paciente e profissional.

2. Atuação em equipe

O técnico integra a equipe de enfermagem. Desenvolve atividades compatíveis com sua formação e participa da programação da assistência. A lei e o decreto reservam determinadas atribuições ao enfermeiro, especialmente cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida e atividades de maior complexidade técnica que exijam base científica e decisões imediatas.

Isso não significa passividade. O técnico observa, executa cuidados de sua competência, reconhece alterações, comunica e registra.

3. Supervisão

Atividades de técnicos e auxiliares em instituições e programas de saúde são desempenhadas sob orientação e supervisão de enfermeiro, nos termos da legislação.

4. Aplicação prática

Situação 1 - Procedimento não dominado

Receber solicitação não transforma procedimento em competência automática. Se houver dúvida sobre limite, técnica ou condição de segurança, o profissional deve esclarecer e buscar supervisão.

Situação 2 - Alteração clínica

O técnico identifica piora respiratória. Não precisa aguardar diagnóstico médico para comunicar imediatamente. Reconhecer risco e acionar equipe é parte da responsabilidade.

Situação 3 - Registro

Executar cuidado e não registrá-lo compromete continuidade. O registro deve representar fielmente o realizado.

5. Erros comuns

- acreditar que supervisão elimina responsabilidade individual;
- executar procedimento sem domínio técnico;
- deixar de comunicar alteração;
- confundir colaboração em equipe com atuação fora da competência;
- omitir registro.

6. O que mais cai

- atuação em equipe;
- supervisão pelo enfermeiro;
- limites profissionais;
- responsabilidade;
- importância de comunicação e registro.

7. Questões comentadas

1. O técnico de enfermagem:

- A) atua sem supervisão em qualquer circunstância
- B) integra a equipe e atua dentro da competência, sob orientação e supervisão do enfermeiro nos contextos legais
- C) substitui integralmente o enfermeiro
- D) pode executar procedimento que não domina se solicitado

Resposta: B.

2. A supervisão:

- A) elimina responsabilidade do técnico
- B) não autoriza prática insegura
- C) dispensa registro
- D) impede comunicação de riscos

Resposta: B.

8. Resumo do capítulo

Lei, decreto e Código de Ética formam base de atuação. Trabalhar em equipe exige competência, supervisão, comunicação e responsabilidade.

Capítulo 15 - Assistência clínica aprofundada

1. Introdução

O edital cobra enfermagem clínica. Para o técnico, a prioridade é reconhecer necessidades, executar cuidados previstos, observar resposta e comunicar sinais de agravamento. Não se exige formular diagnóstico médico, mas identificar mudanças com rapidez.

2. Diabetes mellitus

Diabetes envolve alteração da glicemia. O cuidado pode incluir controle conforme prescrição, observação de alimentação, medicações e sinais clínicos.

Hipoglicemia

Pode ocorrer com queda da glicose. Sinais possíveis:

- sudorese;
- tremor;
- fraqueza;
- fome;
- palidez;
- irritabilidade;
- confusão;
- sonolência;
- perda de consciência.

Hiperglicemia

Pode envolver sede intensa, urina frequente, desidratação, fraqueza e alteração clínica progressiva. A interpretação depende do quadro e de dados mensurados.

Caso comentado: paciente em uso de insulina apresenta suor frio, tremores e fala confusa. O técnico deve reconhecer possível urgência, verificar dados conforme protocolo, comunicar e seguir orientação. Não deve aguardar melhora espontânea.

3. Hipertensão e condições cardiovasculares

Observe pressão arterial, pulso, perfusão, dor torácica, dispneia, edema e mudanças súbitas. Dor no peito associada a sudorese e mal-estar exige comunicação imediata.

Pegadinha

Uma aferição alterada precisa ser comunicada e contextualizada. Também é importante conferir técnica: manguito inadequado ou posição errada pode distorcer medida.

4. Condições respiratórias

Em pneumonia, asma, bronquite ou outras condições, observe:

- frequência e padrão respiratório;
- esforço;
- tosse;
- secreção;
- coloração;
- nível de consciência;
- saturação quando monitorada;
- resposta à oxigenoterapia ou nebulização prescrita.

Caso comentado: paciente passa a usar musculatura acessória e apresenta fala entrecortada. A conduta é observar rapidamente, comunicar e seguir protocolo, não apenas registrar no fim do plantão.

5. Condições renais

Observe diurese, edema, pressão arterial, peso quando previsto e balanço hídrico. Redução importante da diurese ou mudança clínica deve ser comunicada.

6. Erros comuns

- aguardar diagnóstico para comunicar risco;
- olhar apenas um valor;

- ignorar mudança em relação ao padrão do paciente;
- deixar de registrar resposta a cuidado;
- oferecer conduta fora de prescrição ou protocolo.

7. O que mais cai

- sinais de hipo e hiperglicemia;
- dor torácica e dispneia como alertas;
- balanço hídrico e diurese;
- comunicação rápida;
- técnica de aferição.

8. Questões comentadas

1. Sudorese, tremor e confusão em pessoa com diabetes:

- A) podem indicar hipoglicemia e exigem avaliação rápida
- B) devem ser ignorados
- C) são sempre normais
- D) dispensam comunicação

Resposta: A.

2. Redução importante da diurese:

- A) não interessa ao balanço
- B) deve ser observada e comunicada
- C) é sempre esperada
- D) dispensa registro

Resposta: B.

9. Resumo do capítulo

Na assistência clínica, o técnico protege o paciente ao reconhecer alterações, executar cuidados seguros e comunicar oportunamente.

Capítulo 16 - Assistência perioperatória aprofundada

1. Períodos cirúrgicos

Período	Ideia central
Pré-operatório	preparação e redução de riscos antes do procedimento
Transoperatório	segurança durante procedimento
Pós-operatório	vigilância da recuperação e reconhecimento de complicações

2. Pré-operatório

Conforme rotina e planejamento, observe identificação, jejum, alergias, preparo prescrito, exames disponíveis, sinais vitais, orientações, adornos, dispositivos e checklist.

Exemplo: jejum não deve ser presumido. Confirme registro e comunique divergência.

3. Pós-operatório

Observe consciência, dor, sinais vitais, respiração, curativos, sangramento, drenos, eliminações, perfusão, náuseas e resposta aos cuidados.

Alertas

- sangramento crescente;
- queda de pressão acompanhada de sinais clínicos;
- alteração respiratória;
- redução de consciência;
- dor intensa ou piora inesperada;
- débito ou aspecto alterado de dreno.

4. Segurança cirúrgica

A identificação correta, a comunicação da equipe e o checklist reduzem eventos evitáveis. O protocolo de cirurgia segura inclui etapas de verificação nos momentos definidos pelo serviço.

5. Erros comuns

- tratar checklist como burocracia;
- registrar sem comunicar sinal urgente;

- ignorar alergia;
- presumir preparo;
- manipular dreno sem observar fixação e orientação.

6. O que mais cai

- períodos operatórios;
- checklist;
- jejum e alergias;
- sinais de sangramento;
- vigilância no pós-operatório.

7. Questão comentada

1. No pós-operatório, sangramento crescente no curativo:

- A) deve ser comunicado prontamente
- B) é sempre irrelevante
- C) dispensa observação
- D) autoriza retirada livre do curativo

Resposta: A.

8. Resumo do capítulo

Assistência perioperatória é sequência de verificações e vigilância. Segurança depende de reconhecer riscos antes, durante e depois.

Capítulo 17 - Terapia intensiva e criança com suporte respiratório

1. Introdução

Em terapia intensiva, pequenas alterações podem indicar deterioração. O técnico atua em equipe, sob supervisão, com monitoramento e registros precisos.

2. Vigilância do paciente crítico

Observe:

- consciência;
- padrão respiratório;

- perfusão;
- sinais vitais;
- dor;
- dispositivos;
- integridade da pele;
- balanço hídrico;
- alarmes;
- resposta aos cuidados.

Alarmes não devem ser silenciados sem identificar causa. Equipamento auxilia avaliação, mas não substitui observação direta.

3. Crianças intubadas, traqueostomizadas e sob assistência ventilatória

O edital destaca esse cuidado. Crianças possuem particularidades anatômicas e clínicas e podem deteriorar rapidamente. O técnico deve observar:

- fixação do dispositivo;
- permeabilidade conforme sinais;
- padrão respiratório;
- expansão torácica;
- coloração;
- secreções;
- nível de consciência;
- integridade da pele;
- alarmes;
- parâmetros observáveis e orientações da equipe.

Segurança

Mobilização, higiene e troca de posição exigem atenção à fixação. Deslocamento acidental é emergência. Comunique qualquer alteração prontamente.

4. Humanização na UTI

Mesmo com tecnologia e dispositivos, paciente continua sujeito de direitos. Explique cuidado quando possível, preserve privacidade e acolha familiares conforme regras da unidade.

5. Erros comuns

- olhar apenas monitor;

- silenciar alarme sem avaliar;
- movimentar sem conferir dispositivos;
- esquecer prevenção de lesão por pressão;
- reduzir criança a parâmetros.

6. O que mais cai

- monitoramento contínuo;
- dispositivos respiratórios;
- alarme como sinal de investigação;
- prevenção de infecção;
- comunicação rápida;
- humanização.

7. Questões comentadas

1. Ao ouvir alarme em ventilação:

- A) desligue sem observar
- B) avalie paciente e equipamento e comunique conforme necessidade
- C) ignore se paciente estiver dormindo
- D) aguarde próximo plantão

Resposta: B.

2. Antes de mobilizar criança traqueostomizada:

- A) confira fixação e dispositivos
- B) desconecte equipamento livremente
- C) ignore secreções
- D) retire fixação

Resposta: A.

8. Resumo do capítulo

Terapia intensiva exige vigilância, técnica, comunicação e cuidado humanizado. Em crianças com suporte respiratório, dispositivos e sinais de deterioração merecem atenção contínua.

Capítulo 18 - Procedimentos e segurança: aplicação passo a passo

1. Por que estudar por etapas

Uma técnica segura não é uma sequência decorada sem sentido. Cada etapa reduz risco. Em prova, a banca pode remover uma conferência ou inverter a ordem para criar alternativa errada.

2. Antes de qualquer procedimento

Use um roteiro mental:

1. confira prescrição, plano ou indicação;
2. identifique corretamente o paciente;
3. explique o cuidado;
4. higienize as mãos;
5. reúna material;
6. preserve privacidade;
7. avalie riscos;
8. execute conforme técnica e protocolo;
9. observe resposta;
10. descarte materiais corretamente;
11. higienize as mãos conforme indicação;
12. registre e comunique alterações.

Pegadinha

Número do leito não substitui identificadores. Procedimento "rotineiro" também exige identificação.

3. Administração de medicamentos

Antes

- leia prescrição integralmente;
- confira alergias registradas;
- padronize unidades;
- observe via e horário;
- esclareça dúvida;
- evite interrupções durante preparo.

Durante

- confirme paciente;
- explique;
- confira acesso ou condição pertinente;
- administre na via e velocidade prescritas;
- observe desconforto.

Depois

- descarte;
- registre;
- observe resposta e eventos adversos;
- comunique intercorrências.

Caso comentado: prescrição pede 0,25 g ; ampola possui 500 mg/2 mL . Primeiro converta: 0,25 g = 250 mg . Depois calcule $250 \times 2 / 500 = 1 \text{ mL}$.

4. Coleta de material

Evite troca de amostra. Confirme identidade, recipiente, preparo, identificação e encaminhamento. Uma amostra corretamente coletada, mas identificada de forma errada, permanece insegura.

5. Curativo

Observe lesão e pele ao redor. Siga técnica e cobertura prescritas ou protocoladas. Documente características relevantes.

Erros de prova

- retirar cobertura sem preparar material;
- ignorar dor;
- não observar exsudato;
- registrar apenas "curativo realizado" quando há alteração relevante.

6. Prevenção de quedas

Avalie risco individual, ambiente, mobilidade, dispositivos, calçado e necessidade de ajuda. Oriente paciente e acompanhante conforme plano.

Caso comentado: pessoa tenta caminhar após medicação e relata tontura. A resposta segura é oferecer auxílio, reavaliar e comunicar conforme necessidade, não incentivar caminhada independente.

7. Prevenção de lesão por pressão

O protocolo institucional deve prever avaliação de risco na admissão e durante internação e medidas conforme risco.

Medidas combinadas

- avaliar pele;
- controlar umidade;
- reposicionar;
- observar nutrição;
- usar superfície de apoio quando indicada;
- cuidar de dispositivos;
- orientar paciente e família;
- registrar.

8. Erros comuns

- decorar etapa sem compreender risco;
- ignorar resposta após procedimento;
- registrar de modo genérico;
- esquecer descarte;
- imaginar que um cuidado isolado previne todos os eventos.

9. O que mais cai

- identificação;
- higienização;
- conferências de medicamentos;
- ordem lógica da coleta;
- prevenção multifatorial;
- observação e registro.

10. Questões comentadas

1. Antes de coleta, a identificação:

- A) pode ser feita apenas pelo leito
- B) deve seguir identificadores protocolados
- C) é dispensável em paciente conhecido
- D) ocorre somente após envio

Resposta: B.

2. Prevenção de lesão por pressão:

- A) depende de medida única
- B) combina avaliação de risco e intervenções
- C) exclui pele e umidade
- D) não envolve dispositivos

Resposta: B.

3. Após procedimento:

- A) resposta do paciente não interessa
- B) observe, registre e comunique alteração
- C) descarte é opcional
- D) higienização é desnecessária

Resposta: B.

11. Resumo do capítulo

Segurança nasce da sequência consciente: conferir, explicar, executar, observar, registrar e comunicar.

Capítulo 19 - Oficina prática: sinais vitais

1. Leitura clínica responsável

Aferir não é apenas obter número. É garantir técnica, observar tendência e reconhecer quando comunicar. Valores de referência dependem do contexto; evite transformar apostila em tabela rígida.

2. Temperatura

Considere local, equipamento, horário, ambiente e condição. Registre conforme protocolo. Febre pode exigir observação de sinais associados.

3. Pulso

Além da frequência, observe ritmo e amplitude quando aplicável. Alteração súbita merece comunicação.

4. Respiração

Conte de forma adequada e observe esforço, profundidade, ritmo, secreção, tosse, fala entrecortada, coloração e consciência.

5. Pressão arterial

Use manguito compatível, braço apoiado, posição adequada e técnica protocolada. Medida alterada pode exigir repetição correta e comunicação.

6. Dor

Investigue intensidade, local, início, duração, característica e fatores associados. Reavalie após cuidado.

7. Erros comuns

- registrar sem comunicar;
- usar manguito inadequado;
- contar respiração sem observar esforço;
- ignorar dor;
- comparar valores sem contexto.

8. Questões comentadas

1. Ao medir pressão:

- A) manguito não interfere
- B) técnica e tamanho do manguito importam
- C) posição é irrelevante
- D) registro é dispensável

Resposta: B.

2. Na respiração:

- A) apenas frequência importa
- B) observe também esforço e padrão
- C) cianose é irrelevante
- D) fala entrecortada não interessa

Resposta: B.

9. Resumo

Sinais vitais são informação clínica: técnica, contexto, registro e comunicação são inseparáveis.

Capítulo 20 - Oficina prática: coleta de materiais

1. Princípio

Resultado confiável depende da fase pré-analítica. Troca, contaminação, atraso ou recipiente incorreto podem comprometer exame.

2. Identificação segura

O protocolo de identificação busca garantir que cuidado seja prestado à pessoa correta. Mesmo conhecendo paciente, confira identificadores. Na coleta, relacione paciente, solicitação e amostra.

3. Fluxo

1. confira solicitação;
2. confirme preparo;
3. identifique paciente;
4. explique;
5. reúna recipiente;
6. higienize mãos e use EPI;
7. colete;
8. identifique amostra conforme protocolo;
9. acondicione;
10. encaminhe no prazo;
11. registre.

4. Casos

Recipiente sem identificação

Não encaminhe como se estivesse seguro. Siga protocolo institucional para amostra inadequada.

Material aguardando transporte

Observe condições e prazo. Algumas amostras exigem cuidados específicos.

5. Erros comuns

- confiar apenas no leito;
- rotular inadequadamente;

- esquecer preparo;
- usar recipiente incompatível;
- atrasar envio.

6. Questões comentadas

1. Mesmo conhecendo paciente:

- A) dispensa conferência
- B) confira identificação
- C) use apenas leito
- D) identifique depois sem protocolo

Resposta: B.

7. Resumo

Coleta segura liga paciente, solicitação, recipiente, identificação e encaminhamento.

Capítulo 21 - Oficina prática: curativos

1. Objetivo

Curativo protege, favorece ambiente adequado e permite acompanhar evolução. Cobertura e frequência dependem de avaliação, prescrição ou protocolo.

2. Avaliação

Observe:

- localização;
- extensão;
- leito;
- bordas;
- pele ao redor;
- exsudato;
- odor;
- dor;
- sinais inflamatórios;
- resposta ao cuidado.

3. Segurança

Prepare material, explique, preserve privacidade, higienize mãos e use técnica indicada. Descarte corretamente e registre achados relevantes.

4. Caso comentado

Durante troca, há aumento de secreção, odor e dor. Não basta escrever "curativo realizado". Registre achados e comunique para avaliação.

5. Bandagem

Após bandagem, observe perfusão e conforto. Palidez, cianose, frio, edema ou dor crescente sugerem problema.

6. Erros comuns

- não observar pele ao redor;
- escolher cobertura por hábito sem avaliação;
- ignorar dor;
- apertar bandagem;
- registrar genericamente.

7. Questões comentadas

1. Curativo com aumento de exsudato e dor:

- A) exige registro e comunicação
- B) deve ser ignorado
- C) sempre é esperado
- D) dispensa observação

Resposta: A.

8. Resumo

Curativo é cuidado técnico e oportunidade de avaliação.

Capítulo 22 - Oficina prática: cálculo medicamentoso

1. Estratégia

1. leia prescrição;
2. identifique unidade;
3. converta quando necessário;
4. organize proporção;
5. calcule;
6. verifique coerência;
7. esclareça dúvida.

2. Dose e volume

$$\text{volume} = \text{dose prescrita} \times \text{volume disponível} / \text{dose disponível}$$

Exemplo 1

Prescrito 300 mg ; disponível 600 mg/4 mL .

$$300 \times 4 / 600 = 2 \text{ mL} .$$

Exemplo 2 com conversão

Prescrito 0,5 g ; disponível 250 mg/2 mL .

$$0,5 \text{ g} = 500 \text{ mg} .$$

$$500 \times 2 / 250 = 4 \text{ mL} .$$

3. Gotejamento

$$\text{gotas/min} = \text{volume} \times \text{fator} / \text{tempo em minutos}$$

Exemplo

1.000 mL em 8 h , fator 20 gotas/mL .

Tempo: $8 \times 60 = 480 \text{ min} .$

$$1.000 \times 20 / 480 = 41,66 .$$

Resultado aproximado conforme protocolo: 42 gotas/min .

4. Erros comuns

- não converter grama;
- usar horas na fórmula de minutos;
- esquecer fator do equipo;
- arredondar sem critério;
- aceitar resposta incoerente.

5. Questões comentadas

1. Prescrito 750 mg; disponível 1,5 g/3 mL. Volume:

- A) 0,5 mL
- B) 1 mL
- C) 1,5 mL
- D) 3 mL

Resposta: C. $1,5 \text{ g} = 1.500 \text{ mg}$; $750 \times 3 / 1.500 = 1,5$.

2. 0,25 g correspondem:

- A) 25 mg
- B) 250 mg
- C) 2.500 mg
- D) 0,025 mg

Resposta: B.

6. Resumo

Cálculo seguro depende de unidade, proporção e conferência crítica.

Capítulo 23 - Laboratório de exercícios: cálculo medicamentoso

Conexão com o Capítulo 22

O Capítulo 22 explica o método e resolve os primeiros exemplos. Este laboratório amplia treino graduado de dose, volume e gotejamento.

1. Método seguro

Antes de calcular:

1. leia a prescrição;
2. destaque dose prescrita;
3. leia apresentação disponível;
4. converta unidades;
5. aplique proporção;
6. confira se resposta é plausível;
7. esclareça dúvida antes de administrar.

2. Exercícios resolvidos: dose e volume

Exercício 1

Prescrito 400 mg . Disponível 800 mg/4 mL .

$$400 \times 4 / 800 = 2 \text{ mL} .$$

Exercício 2

Prescrito 0,3 g . Disponível 150 mg/mL .

Converta: 0,3 g = 300 mg .

$$300 / 150 = 2 \text{ mL} .$$

Exercício 3

Prescrito 125 mg . Disponível 250 mg/5 mL .

$$125 \times 5 / 250 = 2,5 \text{ mL} .$$

Exercício 4

Prescrito 1 g . Disponível 500 mg/2 mL .

Converta: 1 g = 1.000 mg .

$$1.000 \times 2 / 500 = 4 \text{ mL} .$$

3. Exercícios resolvidos: gotejamento

Exercício 5

500 mL em 4 h , equipo com 20 gotas/mL .

Tempo: 4 x 60 = 240 min .

$$500 \times 20 / 240 = 41,66 .$$

Resultado aproximado: 42 gotas/min .

Exercício 6

1.000 mL em 10 h, fator 20 gotas/mL.

Tempo: 600 min.

$$1.000 \times 20 / 600 = 33,33.$$

Resultado aproximado: 33 gotas/min.

4. Exercícios para fixação

1. Prescrito 600 mg; disponível 1.200 mg/6 mL:

- A) 1 mL
- B) 2 mL
- C) 3 mL
- D) 6 mL

Resposta: C. $600 \times 6 / 1.200 = 3$.

2. Prescrito 0,75 g; disponível 250 mg/mL:

- A) 1 mL
- B) 2 mL
- C) 3 mL
- D) 4 mL

Resposta: C. $0,75 \text{ g} = 750 \text{ mg}; 750/250 = 3$.

3. 300 mL em 3 h, fator 20 gotas/mL:

- A) 20 gotas/min
- B) 33 gotas/min
- C) 60 gotas/min
- D) 100 gotas/min

Resposta: B. $300 \times 20 / 180 = 33,33$.

5. Pegadinhas

- misturar g e mg;
- usar hora sem converter;
- esquecer fator;
- trocar dose prescrita e disponível;
- aceitar resultado absurdo;
- arredondar sem observar protocolo.

6. Resumo

Cálculo correto não substitui conferência clínica. Dúvida interrompe administração até esclarecimento.

Capítulo 24 - Estudos de caso por procedimento

1. Caso: sinais vitais

Após aferição, pressão está muito diferente do padrão. Antes de concluir, confira técnica e repita conforme protocolo; observe sintomas e comunique.

Aprendizado

Medida exige técnica e interpretação. Nem ignore alteração nem trate número isolado como diagnóstico.

2. Caso: coleta

Dois pacientes têm nomes semelhantes. A etiqueta está pronta, mas você ainda não confirmou identificadores.

Conduta

Confirme paciente conforme protocolo e associe amostra à pessoa correta. Conhecer visualmente não dispensa identificação.

3. Caso: curativo

Durante troca, há odor, aumento de exsudato e dor.

Conduta

Observe, registre características e comunique para avaliação. Não use registro genérico.

4. Caso: cateter vesical

O sistema apresenta dobra e redução de fluxo.

Conduta

Observe posicionamento, evite manipulação desnecessária, corrija conforme competência e protocolo e comunique persistência ou sinais clínicos.

5. Caso: oxigenoterapia

Paciente apresenta desconforto e dispositivo mal posicionado.

Conduta

Confira dispositivo, fluxo prescrito, resposta e necessidade de comunicação. Não altere fluxo livremente.

6. Caso: lesão por pressão

Pessoa acamada apresenta vermelhidão persistente em proeminência óssea.

Conduta

Comunique, registre, reavalie medidas preventivas e siga plano individualizado.

7. Caso: pós-operatório

Curativo apresenta sangramento crescente e paciente está pálido.

Conduta

Comunique imediatamente. Registro posterior não substitui resposta oportuna.

8. Erros comuns

- omitir informação;
- agir além da competência;
- registrar vagamente;
- ignorar protocolo;
- tratar equipamento como substituto da observação.

9. Questões comentadas

1. Dois pacientes com nomes semelhantes exigem:

- A) uso do leito apenas
- B) conferência de identificadores
- C) identificação posterior
- D) nenhuma medida

Resposta: B.

2. Vermelhidão persistente em proeminência óssea:

- A) deve ser ignorada
- B) exige observação, registro e comunicação

- C) autoriza massagem automática
D) não interessa à prevenção

Resposta: B.

10. Resumo

Procedimentos seguros combinam técnica, vigilância, limites, registro e comunicação.

Capítulo 25 - Revisão e simulado

Como a banca costuma cobrar cada eixo

Eixo	O que mais cai	Erro frequente
Humanização	privacidade, explicação e escuta	confundir humanização com ausência de protocolo
Registros	objetividade, horário e comunicação	usar julgamento vago
Sinais vitais	técnica e comunicação de alteração	interpretar valor isolado sem contexto
Medicamentos	conferências, unidades e cálculo	administrar diante de dúvida
CME	crítico, semicrítico, não crítico e fluxo	ignorar limpeza prévia
Coletas	identificação e encaminhamento	coletar no recipiente inadequado
Lesão por pressão	prevenção multifatorial	tratar reposicionamento como única medida
Curativos	aspecto, exsudato, pele e dor	não observar perfusão após bandagem
Oxigenoterapia	prescrição, fluxo e segurança	tratar oxigênio como medida livre
Sondas e cateteres	indicação, fixação e vigilância	manipular desnecessariamente
Balanço hídrico	entrada, saída e cálculo	esquecer medicamentos diluídos
IRAS	mãos, EPI e precauções	achar que luvas substituem higiene
Cirurgia	identificação, checklist e vigilância	retardar comunicação no pós-operatório
Clínica e UTI	reconhecer deterioração	aguardar fechamento diagnóstico
Ética	competência, sigilo e responsabilidade	omitir intercorrência

Estudos de caso comentados

Caso 1 - Acesso venoso com alteração

Durante infusão, o paciente relata dor. Há edema próximo ao acesso. A conduta não é acelerar solução nem ignorar queixa. O técnico deve interromper conforme protocolo, observar, comunicar e registrar. A situação pode indicar complicação local e exige avaliação.

Caso 2 - Material com embalagem úmida

Um pacote processado está íntegro visualmente, mas úmido. Não deve ser utilizado como estéril. A umidade compromete confiabilidade da barreira.

Caso 3 - Queda sem lesão aparente

Mesmo sem queixa imediata, queda precisa ser comunicada, avaliada e registrada conforme protocolo. A ausência de lesão visível não autoriza omissão.

Caso 4 - Informação urgente

Paciente com redução súbita de consciência exige comunicação imediata. Registro posterior é necessário, mas não substitui acionamento oportuno.

Quadro de revisão rápida

Tema	Ponto-chave
Humanização	cuidado seguro, respeitoso e centrado na pessoa
Registro	objetivo, cronológico, verdadeiro e oportuno
Sinais vitais	medir corretamente, interpretar contexto e comunicar alteração
Medicamentos	conferir paciente, medicamento, dose, via, horário e registro
Esterilização	elimina todas as formas microbianas, inclusive esporos
Lesão por pressão	prevenção multifatorial e individualizada
Oxigênio	medicamento; exige prescrição e vigilância
Balanço hídrico	entradas menos saídas
IRAS	mãos, EPI, descarte e protocolos
Ética	limites da competência, sigilo e responsabilidade
Exercício profissional	equipe, supervisão, limites legais e registro
CME	crítico esteriliza; semicrítico desinfeta em alto nível no mínimo; não crítico limpa no mínimo
Identificação	use identificadores protocolados; leito não basta
Cálculo	padronize unidades antes de calcular

Simulado comentado

1. Sinal é:

- A) relato subjetivo apenas
- B) dado observável ou mensurável
- C) julgamento do profissional
- D) diagnóstico definitivo

Resposta: B.

2. Prescrição de 400 mg. Disponível: 800 mg em 4 mL. Volume:

- A) 1 mL
- B) 2 mL
- C) 4 mL
- D) 8 mL

Resposta: B. $400 \times 4 / 800 = 2$.

3. Em balanço hídrico, urina é:

- A) entrada
- B) saída
- C) medicamento
- D) dieta

Resposta: B.

4. Embalagem de material esterilizado rasgada:

- A) preserva esterilidade
- B) compromete segurança do material
- C) deve ser usada primeiro
- D) pode ser fechada manualmente

Resposta: B.

5. A melhor conduta diante de piora respiratória é:

- A) registrar no fim do dia apenas
- B) comunicar prontamente e agir conforme protocolo
- C) aguardar espontaneamente
- D) ignorar se paciente estiver consciente

Resposta: B.

6. Um produto não crítico deve receber, no mínimo:

- A) limpeza
- B) nenhuma medida
- C) esterilização obrigatória em qualquer caso
- D) descarte administrativo

Resposta: A.

7. $1,5 \text{ g}$ equivalem a:

- A) 15 mg
- B) 150 mg
- C) 1.500 mg
- D) 15.000 mg

Resposta: C.

Bloco adicional de questões comentadas

8. O uso de luvas durante cuidado:

- A) substitui higiene das mãos
- B) dispensa troca entre procedimentos

- C) não substitui higiene das mãos
- D) elimina qualquer risco

Resposta: C. Luvas e higiene possuem indicações próprias.

9. Um paciente apresenta dor, edema e vermelhidão em acesso venoso durante infusão. A conduta adequada é:

- A) aumentar velocidade
- B) observar, interromper conforme protocolo e comunicar
- C) ignorar até fim da solução
- D) cobrir e não registrar

Resposta: B.

10. Em coleta de material, é indispensável:

- A) identificar corretamente a amostra
- B) utilizar qualquer recipiente
- C) desconsiderar preparo
- D) aguardar tempo indefinido para encaminhar

Resposta: A.

11. Sonda e cateter:

- A) dispensam observação após instalação
- B) exigem vigilância de fixação, permeabilidade e complicações
- C) podem ser manipulados sem necessidade
- D) não interferem em mobilização

Resposta: B.

12. Uma bandagem seguida de extremidade fria e arroxeadas:

- A) é achado esperado
- B) exige avaliação e comunicação
- C) deve ser apertada
- D) dispensa registro

Resposta: B.

13. Entrada total de 2.000 mL e saída de 2.350 mL resultam em balanço:

- A) +350 mL
- B) -350 mL
- C) +4.350 mL
- D) zero

Resposta: B.

14. No pós-operatório, sangramento relevante:

- A) deve aguardar fim do plantão
- B) exige comunicação imediata

- C) é sempre esperado
- D) não deve ser registrado

Resposta: B.

15. Negligência relaciona-se mais diretamente a:

- A) omissão de cuidado devido
- B) ação tecnicamente perfeita
- C) planejamento regional
- D) higienização adequada

Resposta: A.

16. Material semicrítico:

- A) entra em contato com mucosa íntegra ou pele não íntegra
- B) toca somente pele íntegra
- C) sempre penetra sistema vascular
- D) não precisa limpeza

Resposta: A.

17. Diante de prescrição com dose muito diferente do habitual:

- A) administrar sem conferir
- B) esclarecer antes da administração
- C) reduzir pela metade sozinho
- D) trocar medicamento

Resposta: B.

18. O número do leito:

- A) substitui qualquer identificador
- B) não basta como identificação segura
- C) elimina conferência
- D) é único dado necessário

Resposta: B.

19. Um registro adequado:

- A) descreve fatos, horários e respostas relevantes
- B) contém julgamento ofensivo
- C) pode relatar cuidado não executado
- D) substitui comunicação urgente

Resposta: A.

20. A supervisão pelo enfermeiro:

- A) autoriza procedimento inseguro
- B) não elimina responsabilidade do técnico
- C) dispensa competência
- D) proíbe observação clínica

Resposta: B.

Estratégia de revisão

Ao errar uma questão técnica, não memorize somente a letra. Escreva:

1. qual risco a conduta errada produz;
2. qual princípio orienta a resposta segura;
3. em que etapa do cuidado ocorre a conferência;
4. quando comunicar e registrar.

Bateria técnica complementar

21. Antes de administrar medicamento intravenoso, é importante:

- A) ignorar compatibilidade e acesso
- B) conferir prescrição, acesso e velocidade
- C) decidir dose por hábito
- D) dispensar identificação

Resposta: B.

22. Uma embalagem esterilizada molhada:

- A) mantém garantia automaticamente
- B) deve ser considerada comprometida
- C) pode ser usada se parecer limpa
- D) dispensa inspeção

Resposta: B.

23. Na prevenção de quedas:

- A) ambiente seguro e avaliação de risco são relevantes
- B) basta usar grade sempre
- C) mobilidade não interfere
- D) orientação não ajuda

Resposta: A.

24. Oxigênio:

- A) pode ter fluxo alterado livremente
- B) deve ser tratado como medicamento
- C) não exige segurança contra ignição
- D) dispensa registro

Resposta: B.

25. Em curativo, odor, dor e exsudato:

- A) são irrelevantes
- B) devem ser observados e registrados conforme pertinência

- C) impedem comunicação
- D) são sempre esperados

Resposta: B.

26. Em terapia intensiva, um alarme:

- A) deve ser silenciado sem avaliação
- B) precisa levar à avaliação do paciente e equipamento
- C) não importa
- D) substitui observação

Resposta: B.

27. A higienização das mãos:

- A) pode ser substituída por luvas
- B) possui indicações próprias e permanece essencial
- C) só ocorre no final do plantão
- D) é opcional

Resposta: B.

28. Dor intensa e piora súbita:

- A) devem aguardar rotina
- B) exigem observação e comunicação oportuna
- C) nunca são relevantes
- D) podem ser omitidas

Resposta: B.

29. O balanço hídrico:

- A) compara entradas e saídas
- B) registra apenas urina
- C) ignora soluções intravenosas
- D) não possui unidade

Resposta: A.

30. O técnico atua:

- A) dentro de competência e supervisão previstas
- B) sem responsabilidade individual
- C) substituindo qualquer profissional
- D) sem registrar cuidados

Resposta: A.

Oficina de ética e segurança medicamentosa

Caso 1 - Prescrição ilegível

O profissional não deve adivinhar medicamento ou dose. Precisa esclarecer antes da administração.

Caso 2 - Interrupção no preparo

Interrupções aumentam risco de erro. Ao retomar, refaça conferências necessárias conforme protocolo.

Caso 3 - Procedimento fora da competência

O Código de Ética assegura recusa a atividade sem competência técnica, científica, ética e legal ou sem segurança. Isso não autoriza abandono: comunique e preserve continuidade.

Caso 4 - Exposição indevida

Fotografar paciente ou divulgar informação sem autorização e finalidade adequada viola privacidade e ética.

Questões situacionais adicionais

31. Prescrição ilegível:

- A) exige esclarecimento
- B) autoriza suposição
- C) pode ser ignorada após administração
- D) deve ser completada pelo técnico

Resposta: A.

32. O Código de Ética permite:

- A) recusar atividade fora da competência ou insegura
- B) quebrar sigilo livremente
- C) omitir risco
- D) registrar procedimento não feito

Resposta: A.

33. Os "certos" da medicação:

- A) orientam conferências para administração segura
- B) dispensam observação da resposta
- C) eliminam necessidade de registro
- D) autorizam alterar prescrição

Resposta: A.

34. Após erro ou intercorrência:

- A) esconda o fato
- B) comunique e registre conforme protocolo
- C) apague registros
- D) culpe paciente

Resposta: B.

35. Em cálculo medicamentoso:

- A) unidade é irrelevante
- B) conversões devem preceder cálculo quando necessárias
- C) g e mg são equivalentes
- D) tempo em horas entra sempre sem conversão

Resposta: B.

Checklist final

- ☐ Diferencio sinal e sintoma.
- ☐ Produzo registro objetivo.
- ☐ Entendo cuidados na aferição de sinais vitais.
- ☐ Resolvo cálculo simples de dose e gotejamento.
- ☐ Diferencio limpeza, desinfecção e esterilização.
- ☐ Reconheço medidas de prevenção de lesão por pressão.
- ☐ Entendo cuidados com curativos, bandagens e dispositivos.
- ☐ Calculo balanço hídrico.
- ☐ Aplico precauções padrão.
- ☐ Reconheço riscos no pré e pós-operatório.
- ☐ Identifico sinais de alerta clínico.
- ☐ Diferencio negligência, imprudência e imperícia.
- ☐ Classifico produtos críticos, semicríticos e não críticos.
- ☐ Confiro identificação protocolar antes de procedimentos.
- ☐ Converto g, mg e mL antes do cálculo.
- ☐ Reconheço sinais de deterioração e comunico rapidamente.
- ☐ Entendo limites de atuação e supervisão profissional.

Matriz final de revisão técnica

Eixo	Conferência essencial	Erro que a banca explora
Humanização	explicar, preservar privacidade e ouvir	tratar técnica como suficiente
Registro	fato, horário, resposta e comunicação	julgamento vago
Sinais vitais	técnica, contexto e tendência	valor isolado
Medicamentos	paciente, fármaco, dose, via, horário, registro e resposta	prescrição duvidosa administrada
Cálculo	unidade, proporção, fator e tempo	g sem converter para mg
CME	limpar, classificar, processar e armazenar	esterilizar sem limpeza
Coleta	solicitação, identificação, recipiente e envio	confiar no leito
Curativo	lesão, pele, exsudato, odor, dor e registro	escrever apenas "realizado"
Dispositivos	indicação, fixação, permeabilidade e vigilância	manipulação desnecessária
Lesão por pressão	risco e medidas combinadas	reduzir prevenção a reposicionamento
IRAS	mãos, EPI, descarte e precauções	luvas substituem higiene
Cirurgia	checklist, alergia, jejum e vigilância	ignorar sangramento
UTI	paciente, alarmes e dispositivos	monitor substituir observação
Ética	competência, supervisão, sigilo e registro	omissão de intercorrência

Simulado técnico final

36. Prescrito 500 mg ; disponível 1 g/4 mL . Volume:

- A) 1 mL
- B) 2 mL
- C) 4 mL
- D) 8 mL

Resposta: B. $1\text{ g} = 1.000\text{ mg}$; $500 \times 4 / 1.000 = 2$.

37. 600 mL em 5 h , fator 20 gotas/mL :

- A) 20 gotas/min
- B) 30 gotas/min
- C) 40 gotas/min
- D) 60 gotas/min

Resposta: C. $600 \times 20 / 300 = 40$.

38. Curativo apresenta odor novo e aumento de dor:

- A) registre e comunique
- B) ignore
- C) aplique qualquer produto
- D) não observe pele

Resposta: A.

39. Antes de coletar amostra:

- A) use somente leito
- B) confira identificadores e solicitação
- C) rotule aleatoriamente
- D) dispense preparo

Resposta: B.

Gabarito concentrado da revisão final

Use depois da resolução. As justificativas completas continuam junto às questões.

Questão	Resposta	Tema
1	B	sinal e sintoma
2	B	cálculo de dose
3	B	balanço hídrico
4	B	integridade de embalagem
5	B	piora respiratória
6	A	processamento mínimo
7	C	conversão de unidade
8	C	luvas e mãos
9	B	acesso venoso
10	A	coleta
11	B	dispositivos
12	B	bandagem
13	B	balanço hídrico
14	B	pós-operatório
15	A	negligência
16	A	semicrítico
17	B	prescrição duvidosa
18	B	identificação
19	A	registro
20	B	supervisão
21	B	medicação IV
22	B	embalagem úmida
23	A	quedas
24	B	oxigênio
25	B	curativo
26	B	alarme

Questão	Resposta	Tema
27	B	higiene das mãos
28	B	comunicação
29	A	balanço
30	A	competência
31	A	prescrição ilegível
32	A	ética
33	A	conferências
34	B	intercorrência
35	B	conversão
36	B	cálculo de dose
37	C	gotejamento
38	A	curativo
39	B	coleta
40	A	UTI
41	B	dor torácica
42	B	limites profissionais

Oficina final: gotejamento e casos clínicos

Exercício 1 - Macrogotas

Prescrito 750 mL em 6 horas , fator 20 gotas/mL .

Tempo: $6 \times 60 = 360 \text{ min}$.

$750 \times 20 / 360 = 41,66$.

Resultado aproximado: 42 gotas/min .

Exercício 2 - Macrogotas

Prescrito 250 mL em 2 horas , fator 20 gotas/mL .

Tempo: 120 min .

$250 \times 20 / 120 = 41,66$.

Resultado aproximado: 42 gotas/min .

Exercício 3 - Microgotas

Prescrito 120 mL em 2 horas , fator 60 microgotas/mL .

Tempo: 120 min .

$$120 \times 60 / 120 = 60 \text{ microgotas/min} .$$

Questões de cálculo

43. 900 mL em 6 h , fator 20 gotas/mL :

- A) 25 gotas/min
- B) 40 gotas/min
- C) 50 gotas/min
- D) 60 gotas/min

Resposta: C. $900 \times 20 / 360 = 50$.

44. 180 mL em 3 h , fator 60 microgotas/mL :

- A) 20 microgotas/min
- B) 40 microgotas/min
- C) 60 microgotas/min
- D) 180 microgotas/min

Resposta: C. $180 \times 60 / 180 = 60$.

45. Prescrito 375 mg ; disponível 750 mg/3 mL :

- A) 0,5 mL
- B) 1 mL
- C) 1,5 mL
- D) 3 mL

Resposta: C. $375 \times 3 / 750 = 1,5$.

Casos clínicos finais

46. Durante infusão, paciente apresenta edema e dor no acesso. A resposta adequada é:

- A) aumentar fluxo
- B) interromper conforme protocolo, avaliar, comunicar e registrar
- C) ignorar
- D) cobrir sem observar

Resposta: B.

47. Paciente no pós-operatório apresenta palidez, sudorese e sangramento crescente no curativo. A prioridade é:

- A) aguardar rotina
- B) comunicar imediatamente e seguir protocolo
- C) oferecer alimento
- D) registrar somente no fim do plantão

Resposta: B.

48. Pessoa com diabetes apresenta tremor, suor frio e confusão. A conduta é:

- A) reconhecer alerta, verificar conforme protocolo e comunicar
- B) aguardar espontaneamente
- C) incentivar caminhada
- D) omitir registro

Resposta: A.

49. Criança traqueostomizada apresenta alteração respiratória após mobilização. O técnico deve:

- A) avaliar dispositivo e paciente e comunicar prontamente
- B) ignorar fixação
- C) silenciar alarmes sem análise
- D) aguardar próxima rotina

Resposta: A.

50. Em coleta, etiqueta e paciente não correspondem. A conduta é:

- A) encaminhar assim mesmo
- B) interromper processo e seguir protocolo de identificação
- C) alterar de memória
- D) usar leito apenas

Resposta: B.

Gabarito do bloco

Questão	Resposta
43	C
44	C
45	C
46	B
47	B
48	A
49	A
50	B

40. Um alarme na UTI:

- A) deve levar à avaliação do paciente e equipamento
- B) deve ser desligado sem análise
- C) substitui contato direto
- D) não importa

Resposta: A.

41. Paciente refere dor torácica e sudorese:

- A) aguarde fim do plantão
- B) observe e comunique prontamente
- C) esconda ocorrência
- D) registre apenas amanhã

Resposta: B.

42. Atividade fora da competência:

- A) deve ser executada sempre
- B) pode ser recusada conforme ética e segurança, com comunicação adequada
- C) dispensa continuidade
- D) deve ser omitida

Resposta: B.

Fontes oficiais e técnicas

- Edital consolidado nº 001/2026 - IDESG
- Código de Ética - Resolução Cofen nº 564/2017
- RDC nº 36/2013 - Segurança do paciente
- Higienização das mãos - Anvisa
- RDC nº 15/2012 - Processamento de produtos para saúde
- Protocolos de Segurança do Paciente - Anvisa
- Protocolo de prevenção de quedas - Anvisa
- Lei nº 7.498/1986 - Exercício da enfermagem
- Decreto nº 94.406/1987 - Regulamentação do exercício da enfermagem
- Protocolo para Cirurgia Segura - Anvisa
- Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos - Anvisa
- Protocolo de identificação do paciente - Biblioteca Digital Anvisa